ORIGEM DO DOCUMENTO:	CHEFIA DE DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM		
TÍTULO:			Nº DOC:
PADRONIZAÇÃO DO CARRO DE EMERGÊNCIA			POP.DE.002
DATA 1ª VERSÃO	DATA DESTA VERSÃO	VERSÃO Nº	PRÓXIMA REVISÃO
01/09/2025	01/09/2025	01	01/09/2027

1. OBJETIVO

1.1 Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem como objetivo padronizar os carros de emergências da Fundação Centro de Controle de Oncologia com medicamentos, materiais e equipamentos;

1.2 Padronizar rotinas de organização, checagem, testagem e limpeza do carrinho de emergência e de seus componentes acessórios (laringoscópios e outros);

1.3 Facilitar o acesso ao indispensável, de forma a agilizar atendimento de urgências e emergência;

1.4 Definir responsabilidades;

1.5 Oferecer assistência segura, eficiente e de qualidade aos pacientes atendidos.

2. ABRANGÊNCIA

2.1 Este POP se aplica aos setores de Internação hospitalar, setores de apoio e serviço de Urgência que necessitam de atendimento emergencial, tais como: parada cardiorrespiratória; comprometimento nas vias aéreas/ventilação; instabilidade hemodinâmica progressiva; choque; hemorragia intensa, erupções cutâneas com comprometimento de vias aéreas, perda súbita do nível de consciência; convulsões; entre outros.

3. PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS E RESPONSÁVEIS

3.1 Equipe Multiprofissional

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8E32.2D3A.33E1.41C1/44650F0D
Código verificador: **8E32.2D3A.33E1.41C1** CRC: **44650F0D**

Documento 8E32.2D3A.33E1.41C1 assinado por: SHIRLEY FRAGOSO MONTEIRO:230******* em 10/12/2025 às 10:54 utilizando assinatura por login/senha.

- Conhecer o conteúdo e a disposição de materiais e de medicamentos contidos no carro de emergência;
- Realizar educação permanente junto a equipe;
- Fazer notificação de qualquer evento adversos relacionados ao carrinho de emergência.

3.2 Médico

- Prescrever os medicamentos utilizados no atendimento, para a reposição do carro de emergência.

3.3 Enfermeiro

- Organizar o carro de emergência e seus componentes acessórios;
- Controlar/conferir os materiais e medicamentos contidos no carro de emergência quanto à sua presença, quantidade, qualidade e validade;
- Monitorar o cumprimento das atividades pelos técnicos de enfermagem, conforme escala de serviço;
- Realizar a testagem funcional do laringoscópio e do desfibrilador e registrar em impresso próprio;
- Conferir os lacres do carro de emergência e registrar em impresso próprio;
- Conferir, listar, quantificar, requerer os medicamentos e os materiais para repor os insumos do carro de emergência que estiverem próximo do vencimento (3 meses);
- Requerer junto à Farmácia os medicamentos padronizados para reposição após conferência do carro;
- Repor os medicamentos utilizados no atendimento de urgência/emergência, mediante prescrição;
- Listar, quantificar, requerer os medicamentos e os materiais do carro de emergência que foram utilizados no atendimento de urgência/emergência.

3.4 Técnico de Enfermagem

- Realizar a limpeza do carro de emergência e do desfibrilador (monitor, cabos e acessórios), conforme escala de serviço e/ou após o atendimento emergencial;

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8E32.2D3A.33E1.41C1/44650F0D
Código verificador: **8E32.2D3A.33E1.41C1** CRC: **44650F0D**

Documento 8E32.2D3A.33E1.41C1 assinado por: SHIRLEY FRAGOSO MONTEIRO:230******* em 10/12/2025 às 10:54 utilizando assinatura por login/senha.

- Auxiliar o enfermeiro na organização e conferência do carro de emergência.

3.5 Farmacêutico/ Técnico em Farmácia

- Dispensar os medicamentos padronizados para reposição do carro, mediante requisição interna, solicitação no sistema ou prescrição médica.

4. DESCRIÇÃO DA ROTINA E PROCEDIMENTO

4.1 Estrutura do carro de emergência

O carro de emergência constitui de um armário móvel contendo rodinhas e com gavetas suficientes para a guarda de medicamentos, materiais e de equipamentos a serem utilizados em situações de emergência e de urgência.

O carro de emergência é composto:

- Base superior: Desfibrilador, caixa com o laringoscópio e lâminas de laringo nº 3 e nº 4; pilhas médias; caixa com materiais de apoio à intubação (umidificador, vacuômetro, borrachas de oxigênio, borrachas de aspiração); monitor multiparamétricos com cabos de monitorização (cabo de PNI, cabo de ECG, oximetro de pulso, cabo de temperatura); impresso de controle de material e medicamento (checklist);

- Lateral: Tábua de compressão e cilindro de oxigênio (apenas em alguns setores);

- Gavetas:

1ª Gaveta	Medicamentos	MEDICAÇÃO
2ª Gaveta	Materiais para acesso intravascular e suporte ventilatório	CIRCULAÇÃO E VIAS AÉREAS
3ª Gaveta	Materiais para cateterismo vesical e gástrico e complementares	COMPLEMENTARES
4ª Gaveta	Soluções e materiais complementares	COMPLEMENTARES

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/8E32.2D3A.33E1.41C1/44650F0D
Código verificador: **8E32.2D3A.33E1.41C1** CRC: **44650F0D**

Documento 8E32.2D3A.33E1.41C1 assinado por: SHIRLEY FRAGOSO MONTEIRO:230******* em 10/12/2025 às 10:54 utilizando assinatura por login/senha.

- A quantidade de carros de emergência por unidade está ajustada conforme o número e o nível de complexidade dos clientes assistidos, além das características da infraestrutura do local;
- O carro de emergência equipado deve ficar posicionado em local estratégico e de fácil acesso e mobilidade;
- As gavetas do carro de emergência devem estar identificadas com tarjas de cores padronizadas, com a descrição de suas respectivas composições (Figura 01);



FIGURA 1: Modelo de Carro de emergência

- O carro de emergência que não estiver em uso deverá permanecer lacrado/fechado. A retirada do lacre deverá ocorrer apenas mediante situações de atendimento às urgências e emergências ou durante a conferência. A relação dos medicamentos, dos materiais e as quantidades utilizadas nos carrinhos de emergências das unidades de atendimentos à pacientes do Fundação Centro de Controle de Oncologia, seguiu as recomendações da ACLS, SBC e AHA, sendo adequada à realidade institucional.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8E32.2D3A.33E1.41C1/44650F0D
Código verificador: **8E32.2D3A.33E1.41C1** CRC: **44650F0D**

Documento 8E32.2D3A.33E1.41C1 assinado por: SHIRLEY FRAGOSO MONTEIRO:230******* em 10/12/2025 às 10:54 utilizando assinatura por login/senha.

- A manutenção do carro de emergência, que sempre deve estar em perfeito estado e pronto para o uso, é de fundamental importância. Para isso, é imprescindível que, após cada utilização, sejam realizadas a reposição e a conferência de todos os materiais e medicamentos; seja utilizado lacre de segurança para assegurar a composição completa do carro; sejam feitas a conferência e o registro diários do lacre, além de teste do monitor/desfibrilador; sejam realizadas manutenções preventivas periódicas do monitor/desfibrilador; e sejam verificadas mensalmente as datas de validade dos materiais e medicamentos, bem como feita sua limpeza do equipamento.

4.2 Rotina de Conferência e Testagem do Carro de Emergência

O carro de emergência e seus componentes acessórios devem ser checados periodicamente quanto à sua integridade/funcionamento.

Unidades do carro de emergência	Atividade	Periodicidade	Responsabilidade
Carro de emergência	Conferência de lacres	Início de cada plantão	Enfermeiro Plantonista
	Controle periódico dos medicamentos e materiais (conferência de quantidade e validade)	Último final de semana do mês	Enfermeiro Plantonista
Desfibrilador	Teste funcional do desfibrilador	Início de cada plantão	Enfermeiro Plantonista
Laringoscópio	Teste funcional de lâminas e laringoscópio	Início de cada plantão	Enfermeiro Plantonista
Cilindro de oxigênio	Controle de quantidade	Início de cada plantão	Enfermeiro Plantonista

Documento 8E32.2D3A.33E1.41C1 assinado por: SHIRLEY FRAGOSO MONTEIRO:230******* em 10/12/2025 às 10:54 utilizando assinatura por login/senha.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/8E32.2D3A.33E1.41C1/44650F0D
Código verificador: **8E32.2D3A.33E1.41C1** CRC: **44650F0D**

- A conferência diária do carrinho de emergência, os testes realizados (laringoscópio e desfibrilador) e o número do lacre devem ser registrados nos formulários padronizados de controle e testagem, datados e assinados (APÊNDICE 1).
- A conferência mensal deve ser documentada no formulário de controle mensal (*check list*), também datado e assinado (APÊNDICES 2, 3 e 4).
- Os medicamentos com prazo de validade a vencer em até 3 meses devem ser substituídos por outros com lotes caso a farmácia tenha com validade superior a 6 meses;
- Caso a Unidade de Dispensação Farmacêutica não possua outros lotes dos medicamentos disponíveis, manter os medicamentos até o prazo de validade e sinalizar no *check list* mensal de conferência.
- O Farmacêutico deverá comunicar a disponibilidade do novo lote e realizar a troca dos medicamentos junto ao Enfermeiro.
- Os medicamentos psicotrópicos devem ser separados em um recipiente específico e identificado (Figura 02);



FIGURA 2: Caixa de psicotrópico

Documento 8E32.2D3A.33E1.41C1 assinado por: SHIRLEY FRAGOSO MONTEIRO:230******* em 10/12/2025 às 10:54 utilizando assinatura por login/senha.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8E32.2D3A.33E1.41C1/44650F0D
Código verificador: **8E32.2D3A.33E1.41C1** CRC: **44650F0D**

- O modo de teste funcional do desfibrilador varia de acordo com a marca do equipamento. Seguir as recomendações do fabricante. O desfibrilador deve estar conectado à rede elétrica, continuamente.
- O teste funcional do laringoscópio deve considerar: lâmpada com boa iluminação; ajuste perfeito do cabo e da lâmina e limpeza. Em caso de não conformidade, o enfermeiro deve providenciar o ajuste imediatamente. A quantidade de laringoscópios, bem como o tipo (reta ou curva) e a numeração das lâminas (0 /1 /2 /3/ 4/ 5), serão ajustados conforme a faixa etária da clientela atendida e o nível de complexidade dos cuidados na unidade.
- A listagem dos itens/*Check list* (descrição e quantidade dos medicamentos e materiais) presentes no carro de emergência, assim como os impressos de controle e testagem, devem estar em uma pasta, localizada em sua base superior.
- Observação: Se o servidor encontrar o lacre do carro de emergência rompido e não conseguir identificar a pessoa responsável pela abertura, o enfermeiro deverá registrar a ocorrência no livro, informar a supervisão de enfermagem do setor e realizar a notificação ao Núcleo de Segurança do Paciente (NSP);

4.3 Rotina de limpeza e desinfecção do carro de emergência

O carro de emergência deve ser submetido às rotinas de limpezas concorrente e terminal, nos prazos definidos, conforme apresentado abaixo:

Unidades do Carro de Emergência	Limpeza/Desinfecção Terminal	Responsável
Carro de emergência	1 vez por mês (externo e interno)	Equipe de enfermagem
Desfibrilador	1 vez por mês e a cada uso	Equipe de enfermagem
Laringoscópio	1 vez por mês e a cada uso	Equipe de enfermagem

A limpeza e desinfecção concorrente/terminal do carro de emergência e do desfibrilador (carcaça, cabos, pás e monitor) devem ser realizadas com compressas úmidas, bem torcidas,

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/8E32.2D3A.33E1.41C1/44650F0D
Código verificador: **8E32.2D3A.33E1.41C1** CRC: **44650F0D**
Documento 8E32.2D3A.33E1.41C1 assinado por: SHIRLEY FRAGOSO MONTEIRO:230******* em 10/12/2025 às 10:54 utilizando assinatura por login/senha.

contendo uma pequena quantidade de sabão neutro (limpeza). Em seguida, devem utilizar uma nova compressa úmida, também bem torcida, para remover o sabão e os resíduos. Por fim, friccionar com uma compressa limpa embebida em álcool a 70% (desinfecção) e ou utilizar desinfetante hospitalar, exceto na tela do monitor, pois o equipamento é sensível à umidade e a produtos corrosivos.

- A desinfecção do laringoscópio deve ser realizada por meio da fricção com compressa embebida em álcool a 70%, simultaneamente à sua testagem funcional.
- Os laringoscópios testados e desinfetados devem ser armazenados em uma caixa limpa e seca, e ou saco plástico apropriado, situado sobre a base superior do carro de emergência;

5. RISCOS RELACIONADOS E AÇÕES PREVENTIVAS

Riscos	Problemas possíveis	Ações Preventivas
Itens em falta ou materiais vencidos	Falta de medicamentos essenciais	Realizar conferência diária dos equipamentos e *check list* mensal
	Equipamentos sem funcionamento adequado	Controle de validade mensal dos materiais e medicamentos
	Materiais estéreis vencidos	Substituição imediata de itens consumidos após uso
Organização inadequada do carro	Dificuldade de localizar materiais em situações críticas	Padronizar a distribuição das gavetas em toda a unidade
	Atrasos na intervenção	Treinar equipes sobre o *layout*
	Aumento de erros assistenciais	Identificação visual clara (etiquetas, cores)
Equipamentos não testados ou com falha	Desfibrilador sem carga	Teste funcional diário do desfibrilador
	Oxímetro ou aspirador não funcionando	Manutenção preventiva programada
	Falha no cilindro de oxigênio	Checagem do nível e pressão do cilindro de oxigênio
Carro de emergência	Perda de tempo crítico durante emergências	Localização fixa e de fácil acesso

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/8E32.2D3A.33E1.41C1/44650F0D
Código verificador: **8E32.2D3A.33E1.41C1** CRC: **44650F0D**

Documento 8E32.2D3A.33E1.41C1 assinado por: SHIRLEY FRAGOSO MONTEIRO:230******* em 10/12/2025 às 10:54 utilizando assinatura por login/senha.

não localizado rapidamente	Atraso na ressuscitação	Treinamento de orientação espacial da equipe
Falta de treinamento da equipe	Manuseio inadequado do carro	Treinamentos periódicos (teóricos e práticos)
	Dificuldade em localizar itens	Simulações realistas de parada cardiorrespiratória
	Erros durante emergências	Avaliações de competência anual
Erros de medicação em situações de urgência	Administração incorreta de dose	Etiquetas claras e padronizadas
	Medicamentos confundidos ou mal identificados	Ampolas organizadas por classe e cor
Carro com mobilidade comprometida	Dificuldade de movimentação em áreas estreitas	Verificação diária das rodinhas e travas
	Risco de queda de materiais.	Substituição de rodas danificadas

6. DEFINIÇÕES E SIGLAS

•**ACLS:** Advanced Cardiovascular Life Support;
• **AHA:** American Heart Association;
• **Cabo de ECG:** Cabo de Eletrocardiograma;
• **Cabo de PNI:** Cabo de Pressão Não Invasiva;
• **NSP:** Núcleo de Segurança do Paciente;
• **POP:** Procedimento Operacional Padrão;
• **SBC:** Sociedade Brasileira de Cardiologia.

7. INDICADORES

Indicador: Conhecimento da Equipe sobre o Carrinho de Emergência

Definição: Nível de conhecimento da equipe sobre o carrinho de emergência, incluindo suas funcionalidades, procedimentos de uso e manutenção.

Fórmula de cálculo: Índice de conhecimento = (Número de respostas corretas / Número total de perguntas) x 100 Unidade de medida: Percentagem (%)

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/8E32.2D3A.33E1.41C1/44650F0D
Código verificador: **8E32.2D3A.33E1.41C1** CRC: **44650F0D**

Documento 8E32.2D3A.33E1.41C1 assinado por: SHIRLEY FRAGOSO MONTEIRO:230******* em 10/12/2025 às 10:54 utilizando assinatura por login/senha.

Meta: Índice de conhecimento ≥ 90%

8. REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987. Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D94406.htm. Acesso em: 10/10/25.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO. Parecer n. 037/2013. São Paulo: COREN-SP, 2013. Disponível em: http://portal.corensp.gov.br/sites/default/files/parecer_coren_sp_2013_37.pdf. Acesso em: 12/10/25.

GOMES, A. G.; GARCIA, A. M.; SCHMIDT, A.; MANSUR, A. P.; VIANNA, C. de B.; FERREIRA, D.; et al. Diretriz de apoio ao suporte avançado de vida em cardiologia – Código Azul – Registro de ressuscitação, normatização do carro de emergência. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, 2003. Disponível em: **https://doi.org/10.1590/S0066-782X2003001800001**. Acesso em: 10/10/25.

PONTES, V. O.; FREIRE, I. L. S.; MENDONÇA, A. E. O.; SANTANA, S. S.; TORRES, G. V. Atualização bibliográfica sobre protocolos para instituição dos carros de emergência. *FIEP Bulletin*, v. 80, Special Edition, Article II, 2010. Disponível em: http://www.fiepbulletin.net/index.php/fiepbulletin/article/viewFile/1676/3265.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 2019. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 113, n. 3, p. 449–663, 2019.

9. APÊNDICES

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/8E32.2D3A.33E1.41C1/44650F0D
Código verificador: **8E32.2D3A.33E1.41C1** CRC: **44650F0D**

Documento 8E32.2D3A.33E1.41C1 assinado por: SHIRLEY FRAGOSO MONTEIRO:230******* em 10/12/2025 às 10:54 utilizando assinatura por login/senha.

10. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	01/09/2025	Elaboração do POP
2	01/09/2027	Revisão do POP

Elaboração: Maria Verbene Costa Aguiar Assinatura: gov.br Documento assinado digitalmente MARIA VERBENE COSTA AGUIAR Data: 10/12/2025 10:18:53-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Data: 10/12/2025
Aprovação: Shirley Fragoso Monteiro – Departamento de Enfermagem Assinatura: SHIRLEY FRAGOSO MONTEIRO:23004363291 Assinado de forma digital por SHIRLEY FRAGOSO MONTEIRO:23004363291 Dados: 2025.12.10 07:51:16 -04'00'	Data: 10/12/2025

Documento 8E32.2D3A.33E1.41C1 assinado por: SHIRLEY FRAGOSO MONTEIRO:230******* em 10/12/2025 às 10:54 utilizando assinatura por login/senha.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8E32.2D3A.33E1.41C1/44650F0D
Código verificador: **8E32.2D3A.33E1.41C1** CRC: **44650F0D**